

16 - 06- La Cirrhose - Pr. Samlani

Bonjour, nous allons voir le cours intitulé la cirrhose. La cirrhose est un syndrome anatomopathologique. On dit cirrhose, on ne dit pas cirrhose du foie.

Parce qu'il n'y a pas d'autre cirrhose. C'est un syndrome anatomopathologique qui associe une atteinte diffuse du foie par un processus qui va associer une fibrose annulaire et des nodules de régénération. Le diagnostic de certitude est histologique et il correspond à l'évolution ultime de la plupart des maladies chroniques du foie.

Regardez ici l'aspect macroscopique. A gauche, c'est un foie qui est normal. Regardez bien sa couleur.

Et à droite, vous avez ce qu'on appelle un foie de cirrhose. Un foie qui est déformé, qui est lobulé, avec un aspect granuleux et une couleur qui est terne. C'est un foie qui est rongé par de la cirrhose.

A la nappate, vous avez un aspect microscopique associant une fibrose multilente détruisant l'architecture normale du parenchyme et qui isole des nodules de régénération, des micros et des macronodules. Comment survient la cirrhose ? Dans un foie normal, il y a un équilibre entre la fibrogénèse et la fibrolyse. Fibrogénèse, c'est la genèse de la fibrose.

La fibrolyse, c'est le phénomène de destruction de la fibrose et du collagène. Quant à des hépatopathies chroniques, il y a une libération de médiateurs d'inflammation et il y aura des lésions hépatocytaires multiples à des degrés variables, et il y aura une activation des cellules étoilées responsable d'une libération de collagène qui va se déposer dans la matrice extracellulaire. La conséquence de cela sera une fibrose annulaire avec apparition de résistance dans les veines portes, donc c'est l'hypertension portale et ses complications.

Rappelez-vous que lorsqu'il y a une diminution de la base fonctionnelle du foie, se produit ce qu'on appelle l'insuffisance hépatocellulaire avec diminution des fonctions du foie, notamment la fonction de synthèse, diminution du TP, du facteur 5, une hypoalbuminémie, une hypocholestérolémie, une diminution du catabolisme des oestrogènes qui va se manifester par une impuissance sexuelle, une épuration des médicaments, une diminution d'épuration des substances toxiques et un nectaire habitué du rubine mixte. La présentation clinique dépendra du stade de la cirrhose. Il faut savoir qu'au début la cirrhose est compensée et que par la suite apparaîtront des signes cliniques et la cirrhose sera dite décompensée.

Elle se manifestera par les signes de l'hypertension portale qu'on a vu qui sont la circulation collatérale, l'acide, l'aspénomégalie et l'apparition de l'acide fera dire qu'il y a une décompensation acétique. Quand il y a une hémorragie par rupture de varices oesophagiennes, on dira qu'il y a une complication hémorragique. La cirrhose peut se manifester par des signes d'insuffisance hépatocellulaire à des degrés variables.

Donc souvent ce sont les complications qui révèlent une cirrhose décompensée. Donc il faut faire la part des choses, différencier entre cirrhose compensée, non décompensée où aucun signe fonctionnel ne peut être présent et qui va durer entre une année à dix ans et la cirrhose décompensée qui se manifestera souvent par des complications acides, hémorragie digestive, encéphalopathie hépatique ou des signes d'insuffisance hépatocellulaire. L'examen clinique sera normal en cas de cirrhose compensée.

Il faut toujours rechercher, faire un examen clinique complet, faire l'examen du foie. Et l'aspect du foie peut être variable, c'est-à-dire strictement normal avec une flèche hépatique normale, une surface normale, un bord antérieur normal. Comme on peut trouver une hépatomegalie diffuse, comme la cirrhose peut se manifester, comme il y a de la fibrose, par une atrophie du foie, donc un foie qui est plus petit.

L'aspect très évocateur de cirrhose est une face antérieure lisse ou granuleuse avec une consistance dure de la face antérieure avec un bord inférieur qui est régulier et tranchant. Et ce foie de cirrhose qui n'est pas compliqué est indolore. Les principaux signes d'hypertension portale seront une splénomégalie, circulation collatérale, une ascite qui est souvent pauvre en protéines, des signes d'insuffisance hépatocellulaire, une asthénie, une encéphalopathie hépatique, un fœtor hépaticus, un ictère et bilirubine mixte, des angiomes stellaires, une érythrose palmo-plantaire ou bien des ongles blancs, un hypocratisme digital, des signes endocriniens ou bien un syndrome hémorragique.

La biologie peut être peu contributive comme elle peut retrouver une anémie qui peut être évocatrice d'un saignement par rupture de varices œsophagiennes ou gastriques, une leucopénie, une thrombopénie quand il y a un hypersplénisme. Dans le cadre d'un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire une baisse du TP peut être retrouvée, une baisse du facteur 5, une hypoalbuminémie, une hypocholestérolémie. L'électrophorèse des protéines peut retrouver un bloc bêta-gamma qui est très évocateur des cirrhoses.

L'échographie abdominale est un examen qui est très utile. Systématiquement répété tous les 6 mois pour dépister le carcinome hépatocellulaire qui est une complication possible de la cirrhose parce que la cirrhose est une condition très cancéreuse. L'échographie va rechercher les modifications des contours du foie, l'aspect hétérogène du parenchyme, des signes d'hypertension portale, notamment dilatation du thrombus, de la veine splénique, d'une splénomégalie ou bien des voies de dérivation portocavales.

Pour l'évaluation pronostique, nous disposons de scores. Le plus utilisé, c'est le calcul du score de Child-Pugh. Ce score, c'est un score qui est clinico-biologique, comme vous voyez, qui regroupe des items cliniques comme l'encéphalopathie, l'ascite, mais également biologique, la bilirubine totale, l'albumine et le taux de prothrombine.

Et il est calculé en points de 1, 2, 3. Ce score permettra donc de faire une évaluation sur le

champ, mais également une évaluation dans le futur, l'évaluation de l'évolution du patient. Entre 5 et 6 points, c'est un Childe A. Entre 7 et 9 points, un Childe B. Et entre 10 et 15 points, c'est un Childe C. Le score de MELD, Model for End Stage Liver Disease, est un score qui est calculé par une transformation logarithmique à partir de trois valeurs de laboratoire, la bilirubine totale, la créatine et l'INR. C'est un score pronostique.

Et qui a aussi un intérêt dans l'évaluation des patients en pré-transplantation hépatique. Pour ce qui est des étiologies de la cirrhose, elles sont dominées par l'alcool, par les hépatites virales, mais également par la stéatohépatite non alcoolique, la nache, l'infiltration du foie par de la graisse, qui sera responsable d'une inflammation et d'une destruction du parenchyme, de la fibrose, donc d'une cirrhose. D'autres étiologies, telles que les maladies auto-immunes, les maladies cholestatiques chroniques, sont également responsables.

En conclusion, il faut scinder deux choses. La cirrhose non décompensée ou bien compensée, où on ne peut trouver aucun signe fonctionnel dont la durée est entre un an et dix ans. Et la cirrhose décompensée par une ascite, compliquée par une hémorragie digestive ou une encéphalopathie hépatique, où les examens vont retrouver en fait les éléments en faveur de complications.

L'examen peut être comme ça, strictement normal ou évocateur de complications. Un autre élément sur lequel il faut insister, c'est que la cirrhose est une condition précancéreuse et que le dépistage est très important par la réalisation d'échographies tous les six mois.